בחינת שלב א' בגריאטריה 2020

1. בת 85, עצמאית ב- BADL וללא חסר קוגניטיבי. ברקע אוסטאופורוזיס, מטופלת בויטמין D ו- ALENDRONATE. בנוסף, יתר לחץ דם שעד כה טופל עם דיאטה ופעילות גופנית , ללא טיפול תרופתי.

בחודשים האחרונים מדידות חוזרות של לחצי דם סביב 165/90.

מהי הגישה הטיפולית המתאימה בחולה זו?

א. המטופלת עם סיכון קרדיו-וסקולרי נמוך. אין צורך בטיפול להורדת לחצי הדם

ב. הימנעות מטיפול ב- HYDOCHLOROTHIASIDE עקב אוסטאופורוזיס

ג. טיפול ב- DOXAZOCIN (CADEX) כקו ראשון

ד. טיפול ב- AMLODIPINE (AMLO) כקו ראשון

2. בן 75, חזר לביתו לאחר אשפוז עם סיבוכים עקב HERPES ZOSTER. אשתו בת 67 חוששת שתחלה גם היא ושואלת לגבי חיסון לעצמה.

מה ההמלצה לגבי חיסון ל- HERPES ZOSTER לגביה?

א. במידה וחלתה בצעירותה באבעבועות רוח, אין טעם שתקבל חיסון

ב. כדאי לבצע את החיסון מאחר והוא מוריד סיכון ל POST HERPETIC NEURALGIA

ג. במידה והאישה מדוכאת חיסון, יש חשיבות יתר לקבלת החיסון

ד. היא צעירה, ובגילה הסיכון לפתח הרפס זוסטר נמוך ולכן עדיף שתתחסן בגיל מבוגר יותר

3. בת 80, שוקלת 65 ק"ג, בבדיקות בקופ"ח רמת קריאטנין בדם 0.8. אושפזה עקב התייבשות ו- Acute Tubular Necrosis (ATN) עם עלייה של הקריאטנין.

בשחרורה - קריאטינין התייצב על 1.5.

כעבור 6 חודשים אושפזה שנית עם עליה נוספת בקריאטנין מ- 1.5 ל- 3.

כעבור 6 חודשים נוספים, אושפזה פעם שלישית עם עליה נוספת בקריאטנין מ- 3 ל- 5.5.

באיזה שלב חלה <u>הירידה</u> החדה ביותר ב-GFR אצל המטופלת?

א. בעליית קריאטנין מ-0.8 ל-1.5

ב. בעליית קריאטנין מ-1.5 ל-3

ג. בעליית קריאטנין מ-3 ל-5.5

ד. בכולם יש ירידה דומה ב-GFR

4. בן 78, הסובל מדמנציה מתקדמת מאושפז במחלקה לסיעוד מורכב עקב פצע לחץ דרגה 4 בטרוכנטר. לאחרונה נצפתה החמרה בהפרשה מהפצע, הופיע אודם מקומי ונמדד חום סיסטמי 38.5.

מה הגישה הטיפולית לזיהום במקרה המתואר?

א. מתן טיפול אנטיביוטי בהתאם לבדיקת מטוש (SWAB) ממוגלה שיוצאת מהפצע

ב. מתן טיפול אנטיביוטי ראשוני המכסה זיהום ב- PSEUDOMONAS AUROGINOSA

ג. מתן טיפול אנטיביוטי ב- CEFAMEZIN היעיל בטיפול בחיידקי עור כמו STREPTOCOCUS ו- STAPHILOCOCUS

ד. מתן טיפול אנטיביוטי אמפירי רחב טווח

5. למרפאה מגיע מטופל בן 76 הסובל מירידה קוגניטיבית מזה כ- 3 שנים. מדווח על ירידה בזיכרון ובהתמצאות בזמן. אשתו מדווחת כי במהלך השנה האחרונה הירידה הקוגניטיבית מביאה לקושי גובר בניהול פעולות אותן היה מבצע היטב עד כה (קניות, נהיגה, עבודה על המחשב, ניהול הטיפול התרופתי, אחזקת בית וכו'). בבדיקת MMSE מתקבל ציון של 24/30.

מה הטיפול התרופתי המומלץ במטופל זה ומדוע?

א. היות ומדובר ב- MCI מומלץ טיפול במעכבי כולין אסטרז שנמצאו יעילים בעיכוב התקדמות מ- MCI למחלת אלצהיימר

ב. מומלץ טיפול ב Memantine, אשר מאושר לשימוש למחלת אלצהיימר בדרגה קלה-בינונית ומאט את קצב הירידה במבחן MMSE

ג. מומלץ טיפול במעכבי כולין אסטרז בחולי אלצהיימר, שכן הוא גורם להאטה של ההחמרה הקוגניטיבית ולשיפור באיכות חיים

ד. מומלץ שילוב של מעכב כולינאסטרז ו- Memantine כיוון שהוכח כי במחלת אלצהיימר בדרגה קלה השילוב יעיל יותר מכל אחת מהתרופות בנפרד בשימור תפקוד

6. בן 88, ללא חסר קוגניטיבי ידוע, אושפז בטיפול נמרץ קרדיולוגי עקב אוטם שריר הלב. בלילה צעק, ניסה לקפוץ מהמיטה ואף הרביץ לאחות שקשרה אותו למיטה.

איזה מהבאים נכון בנוגע לטיפול במצב המתואר?

א. הטיפול התרופתי יעיל מאוד במקרה זה

ב. ההמלצות הטיפוליות כוללות גמילה מקתטר שתן וניתוק ממוניטור

ג. הגבלה פיזית היא חיונית במקרה כזה

ד. מומלץ טיפול בבנזודיאזפינים בשעות בלילה בלבד

7. בת 84, מגיעה להערכה גריאטרית כוללנית ומבקשת הפניה לבדיקת ממוגרפיה. היא מאוד כועסת שהבדיקה אינה בסל הבריאות עבורה.

מה אפשר להסביר לה על התועלת בביצוע ממוגרפיה שגרתית בנשים מעל גיל 75?

א. אין אינדיקציה לבדיקת ממוגרפיה היות וסרטן שד מאוד נדיר בגיל זה

ב. סרטן שד בגיל מבוגר הוא בעל פרוגנוזה טובה יותר

ג. אין הוכחה מחקרית ליעילות ממוגרפיה למניעת תמותה בנשים מעל לגיל 75

ד. לא ניתן להסביר. הבדיקה אינה בסל הבריאות משיקולים כלכליים בלבד

8. בן 75, מעשן כבד, אובחן כסובל מ- COPD (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY) DISEASE. ברקע - יתר לחץ דם וסוכרת. מטופל בתרופות - ASPIRIN, ENALAPRIL ו- METFORMIN.

לאחרונה אושפז עקב החמרה בקוצר נשימה ושוחרר לביתו לאחר שבוע. פנה למרפאה להתייעצות לגבי מניעה של אשפוזים נוספים.

מה מומלץ לצורך מניעת אשפוזים חוזרים?

א. שימוש קבוע במכייחים למניעת הצטברות הפרשות

ב. מתן תוספת של טיפול ב- THEOPHYLLINE

ג. מתן חמצן במשקפיים 2 ליטר/לדקה ללא קשר למצב ריווי החמצן בדם

ד. הפניה לשיקום ריאות

9. בת 85 אובחנה כסובלת מ- Polymyalgia Rheumatica (PMR) .

מה נכון בנוגע למחלה זו?

א. התסמונת שכיחה יותר אצל נשים ביחס של 2:1

ב. 70% מחולי PMR הם בגיל מעל 60

ג. כאבים בחגורת אגן יותר שכיחים מאשר כאבים בחגורת כתפיים

ד. ב- 40% מהחולים יש ארטריטיס ארוזיבי של מפרקי כפות הידיים

10. לפי המאמר Use of the Functional Independence Measure for Outcomes Measurement in Acute Inpatient Rehabilitation מאת Michele Cournan,
מה נכון לגבי ההבדל בין מדד ה- BARTHEL-למדד ה- FIM ?

א. מדד ה - BARTHEL מבוסס על מדד ה- FIM

ב. מדד FIM נועד למדוד את מה שהמטופל "יכול לעשות" , ומדד ה BARTHEL נועד למדוד "נטל טיפול"

ג. מדד BARTHEL נועד למדוד את מה שהמטופל "יכול לעשות" , ומדד ה FIM נועד למדוד "נטל טיפול"

ד. מדד ה - BARHEL הוא מדד בעל אמינות גבוהה יותר לעומת FIM

11. מה מהבאים נכון לגבי תופעות לוואי של טיפול באופיואידים בכאב כרוני בזקנים?

א. עצירות היא תופעת לוואי שמתפתחת לה סבילות (TOLERANCE) עם הזמן

ב. עקב תופעות הלוואי אסור לעבור מינון מקסימלי של אופיואידים (CEILING EFFECT)

ג. PSEUDOADDICTION היא תופעת לוואי המתבטאת בצריכה מופרזת של תרופה משנית לגורמים לא אורגניים

ד. בהפסקה פתאומית של הטיפול יכולים להיות סימני גמילה

12. מה ידוע לגבי סיבוכים פוסט-ניתוחיים של קשישים?

א. כ- 50% מהסיבוכים לאחר הניתוח מופיעים בשבוע הראשון

ב. כ- 25%-30% מהתמותה הפרי-ניתוחית היא משנית לגורמים לבבים

ג. הימנעות ממאמץ גופני בשבועיים שלפני הניתוח יכולה להפחית סיבוכים ניתוחיים

ד. התפתחות מצב בלבולי לאחר הניתוח לא משפיעה על משך האשפוז ותקופת ההחלמה

13. בת 85, סובלת מדמנציה בינוני, מתגוררת בביתה עם עובדת זרה. פנתה למחלקה לרפואה דחופה עקב שלשול וחוסר תיאבון. לדברי המטפלת, האישה סובלת מזה כחודש מצואה נוזלית מספר פעמים ביום, איבדה שליטה על צואה. מתלוננת על כאב בטן וחוסר תיאבון. טיפול ב- LOPERAMIDE (IMODIUM) לא שיפר את המצב.

מה הבדיקה הראשונה שיש לבצע לחולה זו?

א. צילום בטן ריקה

ב. בדיקת צואה ל- CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN

ג. בדיקת צואה לפרזיטים

ד. בדיקה רקטלית

14. אצל בן 75 המאושפז במחלקה אורתופדית לאחר ניתוח נצפה פצע לחץ בעכוז בגודל 7X10 ס"מ, צבע חום-סגול , עור שלם. הצבע לא נעלם לאחר הקלת לחץ.

באיזו דרגה של פצע לחץ מדובר?

א. STAGE 2

ב. STAGE 3

ג. UNSTAGABLE

ד. SUSPECTED DEEP TISSUE INJURY

15. בן 78 , מתהלך, סובל מדמנציה בינונית, מתגורר במחלקה לתשושי נפש. חזר למחלקה לאחר אשפוז בבית חולים כללי, שם היה שבוע מרותק למיטה ונזקק לחיתול. כעת ללא שליטה על שתן. מהו הטיפול הנכון בשבילו?

א. תרגול שרירי רצפת אגן

ב. Tolterodine (דטרוזיטול)

ג. תזמון מסודר של מתן שתן

ד. קתטר חיצוני (פנרוס)

16. על פי המאמר Advanced Dementia של Mitchell אילו קריטריונים נכללים בהגדרה של חולה דמנציה כבעל פרוגנוזה משוערת של פחות מ- 6 חודשים?

א. זקוק לעזרה ברחצה + אירוע אחד של ASPIRATION PNEUMONIA

ב. אומדן MMSE פחות מ- 10 + שני אירועים של מחלת חום ב- 2 חודשים

ג. מרותק לכיסא גלגלים + ירידה במשקל של יותר מ- 10% ב- 6 חודשים

ד. מדבר 5 מילים + צלוליטיס ברגל

17. בן 76, התקבל למחלקת שיקום לאחר שבץ איסכמי - CVA. בבדיקת בליעה נצפתה הפרעה קשה לכל המרקמים ובשיתוף החולה הוחלט על הכנסת NASOGASTIC TUBE ("זונדה") והתחלה של הזנה אנטרלית. תזונאית נתנה תכנית להתחלת ההזנה.

מה ההפרעות המטבוליות שיכולות להתרחש בהתחלת הכלכלה?

א. היפוגליקמיה, היפונתרמיה והיפרקלמיה

ב. היפרגליקמיה, היפוקלמיה והיפופוספטמיה

ג. היפרנתרמיה, היפרגליקמיה והיפופוספטמיה

ד. היפומגנזמיה, היפרקלמיה והיפרקלצמיה

18. עם ההזדקנות מתרחשים שינויים רבים בפרמקוקניטיקה ופרמקודינמיקה של תרופות.

מה מבין הבאים נשמר כמעט ללא שינוי?

א. נפח פיזור התרופה בגוף

ב. מטבוליזם כבדי

ג. הספיגה של התרופה

ד. ההפרשה דרך הכליות

19. על פי ה POCKET GUIDE TO THE 2019 AGS BEERS CRITERIA באיזה מהמצבים הבאים מתאים לטפל בתרופות אנטיפסיכוטיות באנשים מבוגרים?

א. טיפול בהפרעות התנהגות של דמנציה

ב. טיפול במחלה ביפולרית

ג. טיפול ממושך למניעת הקאות במקבלי כימותרפיה

ד. טיפול קצר למניעת דליריום

20. בן 80, מועמד לניתוח להחלפת פרק ירך, אובחן כסובל משבריריות (FRAILITY) על פי הקריטריונים של FRIED. ברקע - סוכרת, אי ספיקת כליות מתקדמת ומחלת לב איסכמית.

מה ההשפעה של השבריריות (FRAILITY) על בעיותיו הרפואיות?

א. העובדה שהמטופל שברירי מעלה סיכון לדלקת ריאות לאחר ניתוח

ב. המטופל יגיע לדיאליזה בערכי GFR נמוכים יותר מאשר אם לא היה שברירי

ג. סיכוי סביר כי אירועים קרדיווסקולריים אצל המטופל יהיו סימפטומטיים לעומת קשישים ללא שבריריות

ד. מאחר שהמטופל שברירי סביר שבבדיקת סבילות לגלוקוז test Glucose tolerance רמות הגלוקוז והאינסולין יהיו נמוכות יותר

21. בן 90 הוא חולה נוטה למות, אשר חתם על מינוי ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות. כעת הוא נמצא באשפוז במחלקה קרדיולוגית בשל סינקופה המיוחסת לחסם הולכתי וזקוק להכנסת קוצב. הצוות המטפל מתלבט האם הוא כשיר לקבל החלטה זו או שיש להכניס לתוקף את ייפוי הכוח.
כיצד יש לקבל החלטה לגבי כשירות מטופל זה על פי חוק החולה הנוטה למות?

א. יש להזמין גריאטר כיוון שרק הוא יכול להחליט על הוצאה מחזקת הכשרות
ב. יש להזמין פסיכיאטר כיוון שרק הוא יכול להחליט על הוצאה מחזקת הכשרות
ג. לצורך הערכת כשירות יש צורך בהערכה קוגניטיבית פורמלית, כמו MOCA על ידי מרפאה בעיסוק
ד. כל רופא שהוגדר כרופא אחראי יכול להוציא מחזקת הכשרות

22. בת 84 מגיעה למרפאה לאחר שנפלה בביתה מספר פעמים. בהערכה עולה כי היא סובלת מאינסומניה מזה כעשר שנים, מאז מות בעלה. מאז מטופלת ב- BROTIZOLAM (BONDORMIN). היא העלתה את המינון על דעת עצמה עד ל- 2 כדורים ללילה. היא מדווחת על מצב רוח שמור ובסקר GDS צברה ניקוד של 3/15.
מה הצעד הבא להמשך הטיפול?

א. הפסקה מידית של BROTIZOLAM בעקבות הנפילות, גם במחיר של הפרעה בשינה
ב. החלפה של הטיפול מ- BROTIZOLAM ל- TRAZODIL
ג. הפחתה הדרגתית של הטיפול ב BROTIZOLAM ובמקביל הפניה לטיפול קוגניטיבי התנהגותי להפרעות שינה
ד. הערכה במעבדת שינה לקביעת דפוס השינה והתאמת טיפול תרופתי

23. מהי התכונה המתאימה לאביזר העזר?

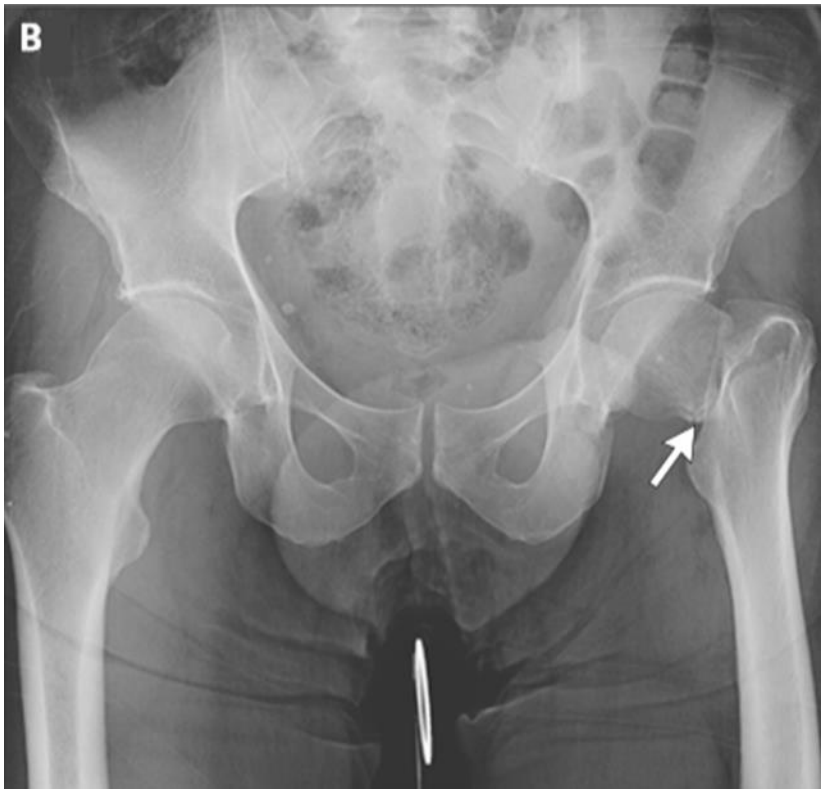
א. מקל נקודה - מוריד נשיאת משקל מהרגל באותו צד
ב. רולטור - יעיל במצב של ללא דריכה על רגל
ג. קלנועית- מחלה קרדיופולמונרית פעילה מהווה קונטראינדיקציה לשימוש
ד. מקל 4 נקודות- מאפשר נשיאת משקל גדולה יותר ממקל נקודה

24. לדיירת במחלקה סיעודית, בת 85, נלקחה תרבית שתן לאחר הופעת חום 38.2.
מה מבין הסימפטומים/סימנים הבאים (בנוסף לחום) מחשיד ל זיהום בדרכי השתן בחולה זו?

א. מאקרוהמטוריה
ב. אירוע של אורוספסיס ב-3 חודשים הקודמים
ג. אצירת שתן
ד. עכירות של השתן

25. גבר בן 73, שמור קוגניטיבית, שנתיים לאחר אירוע מוחי עם חולשת פלג גוף ימין, פנה למלר"ד בעקבות נפילה וחבלה לאגן. עד הנפילה התהלך עם הליכון.

בצילום רנטגן:



מה הטיפול המומלץ לפי המאמר Management of Acute Hip Fracture ?

א. רדוקציה של השבר בחדר ניתוח והשכבה עם מתיחה ל- 3 שבועות

ב. ניתוח arthroplasty, תוך עד 48 שעות מהנפילה, וניוד מוקדם

ג. בשל מגבלת ניידות מלפני הנפילה מומלץ להימנע מניתוח, מומלצת פיזיותרפיה וניוד מוקדם ככל האפשר

ד. ניתוח מיסמור תוך לשדי (intramedullary nails)

26. מה שכיחות הסיבוכים הבאים לאחר שבץ?

א. כ- 25% מהאנשים שנה לאחר שבץ מוחי סובלים מאי שליטה על שתן

ב. כ- 10% מהאנשים הסובלים מחולשת יד יסבלו מכאבים בכתף

ג. כ- 5% מהאנשים לאחר שבץ סובלים מדיכאון

ד. בכ- 30% מהחולים הסובלים מדיספגיה יכולות להופיע אספירציות שקטות

27. בת 78, סובלת מסוכרת לא מאוזנת, ירידה בשמיעה, ופרפור עליות. היא מתגוררת בביתה לבדה, ולאחרונה אובחנה כסובלת מדמנציה. לאחרונה אירעו מספר אירועים: השכנים מצאו אותה משוטטת ברחוב ולא מוצאת את ביתה, הוזמן מכבי אש עקב שריפה שפרצה בדירה מסיר שנשאר על האש. בביקור בית של הרווחה מתברר שלא התרחצה ולא החליפה בגדים זמן ממושך ואכלה מזון מקולקל. הוחלט להעביר אותה למסגרת מוסדית.

מה הסטטוס התפקודי של אישה זו?

א. המטופלת עם ירידה קוגניטיבית, הגורמת לה לפגיעה משמעותית בתפקוד היומיומי ולכן תוגדר כתשושת נפש

ב. המטופלת מתהלכת בעצמה וזקוקה רק לעזרה ב- IADL ולכן תוגדר כתשושה

ג. המטופלת זקוקה להשגחה צמודה ואינה יכולה להתרחץ בעצמה ולכן תוגדר כסיעודית

ד. סוג המסגרת המתאימה תלוי בערך המספרי של מבחן MMSE

28. בן 81, סובל מ- PARKINSON DEMENTIA. MMSE לפי 3 חודשים היה 12/30. תרופות קבועות: ENALAPRIL, DOPICAR, METFORMIN. לדברי בני המשפחה, האיש מתהלך בבית באופן עצמאי עם הליכון גלגלים (ROLATOR) ונופל לעיתים קרובות. לא היה איבוד הכרה ולא ידוע על חבלת ראש. התקבל למרפאה להערכת נפילות חוזרות.

מה כוללת תכנית הברור הראשונית בחולה זה?

א. המלצה לביצוע HOLTER בחשד להפרעות קצב

ב. בדיקת MMSE חוזרת

ג. הערכת יכולת שימוש נכון ב- ROLATOR

ד. המלצה לביצוע MRI מוח

29. בן 92, התקבל במרפאה הגריאטרית בשל תלונות על שינויים קוגניטיביים. הוא אדם פעיל, עצמאי ב- ADL ו- IADL. לדבריו, מזה כשנתיים סובל מקושי במציאת מילים ושטף דיבור. לאחרונה הבחין בנוסף בהפרעה בזיכרון הבאה לידי ביטוי בירידה ביכולת הלמידה. בנו מספר על האטה בזמן התגובה.

מה האבחנה?

א. מאחר ובשנתיים הראשונות התחום הפגוע היחידי היה שפתי, מדובר ב- Primary progressive aphasia.

ב. מדובר ב-dementia אשר הסיבה השכיחה לה הינה מחלת אלצהיימר

ג. המצב המתואר מתאים ל Normal aging

ד. מדובר ב Minimal cognitive impairment- MCI

30. מה מהבאים הוא גורם סיכון לנפילות אצל קשישים?

א. גיל מבוגר

ב. מין זכר

ג. טיפול בתרופות מסוג NSAID

ד. חסר ויטמין B 12

31. בן 93, סובל מדמנציה, מתגורר בביתו עם עובד זר. אושפז במחלקה פנימית עקב החמרה של אי-ספיקת לב. עד לאשפוזו התהלך בביתו עם הליכון. לאחר שבוע אשפוז במחלקה הפנימית הוא מרותק למיטה. בבדיקה גופנית- דלדול שרירים ניכר.

מה האפשרויות הטיפוליות בחולה זה?

א. לצורך שיפור תפקודי מומלצת תזונה עם 0.8 גרם/ק"ג חלבון

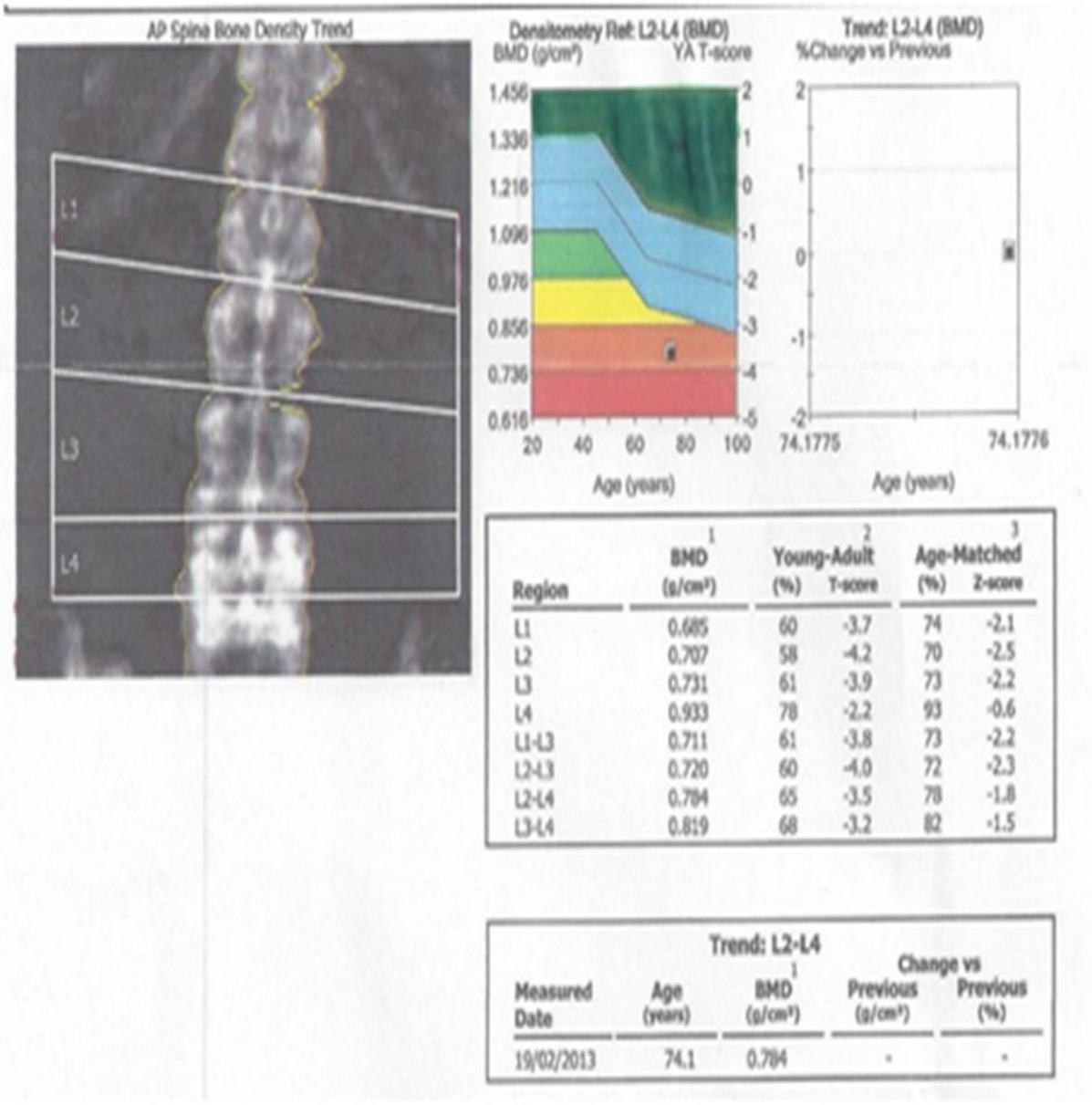
ב. סטרואידים אנאבולים יכולים לעזור בטיפול בסרקופניה

ג. טיפול פיזיותרפי יכול להעלות את מסת השריר

ד. מדובר בחולה סיעודי ואין טיפול יעיל למצבו

32. בת 75, בריאה בדרך כלל, עצמאית ב- ADL, הגיעה להתייעצות במרפאה בשאלה של טיפול לאוסטאופורוזיס.

היא מביאה איתה תשובת בדיקת צפיפות עצם הבאה:



Region	BMD (g/cm²) [1]	Young-Adult (%) [2]	Young-Adult T-score	Age-Matched (%) [3]	Age-Matched Z-score
L1	0.685	60	-3.7	74	-2.1
L2	0.707	58	-4.2	70	-2.5
L3	0.731	61	-3.9	73	-2.2
L4	0.933	78	-2.2	93	-0.6
L1-L3	0.711	61	-3.8	73	-2.2
L2-L3	0.720	60	-4.0	72	-2.3
L2-L4	0.784	65	-3.5	78	-1.8
L3-L4	0.819	68	-3.2	82	-1.5

Trend: L2-L4				
Measured Date	Age (years)	BMD (g/cm²) [1]	Change vs Previous (g/cm²)	Change vs Previous (%)
19/02/2013	74.1	0.784	-	-

מה כוללות ההמלצות התרופתיות?

א. תוספת תכשירי סידן במינון 3000 מ"ג ליום

ב. תוספת ויטמין D במינון 500 יחידות ליום

ג. טיפול ב- ALENDRONAE במינון 70 מ"ג אחת לשבוע

ד. על פי הממצאים בבדיקה אין אינדיקציה לטיפול לאוסטאופורוזיס

33. בן 78 שהיה עצמאי וגר בביתו, התקבל למחלקה לגריאטריה שיקומית לאחר שעבר ניתוח לקיבוע שבר בצואר הירך בעקבות נפילה. הוא שואל "האם אחזור להיות כמו שהייתי לפני הנפילה"?
מה הפרוגנוזה לאחר שבר בצואר הירך?

א. הסיכון לתמותה תוך שנה בגברים לאחר שבר בצואר הירך מגיע ל- 36%
ב. 75% מהאנשים שעברו שבר בצואר הירך יזדקקו לאביזרי עזר בהליכה לאחר שנה
ג. הסיכון לפצעי לחץ לאחר שבר בצואר הירך הוא כ- 10% בחודש הראשון
ד. דיכאון משני לשבר בצואר הירך נשאר בדרך כלל לטווח ארוך לאחר השיפור התפקודי

34. בן 79 מגיע להערכה במרפאה בלווי ביתו, שמספרת על בלבול ומצב רוח ירוד שהופיעו בהדרגה בשנה האחרונה. בשיחה בולטים אפקט דיכאוני וליקוי בקשב. במבחן MMSE השיג תוצאה של 24/30 עם ירידה בזיכרון לטווח קצר והפרעה בחיסור 7 מ- 100. ב- CT מוח נמצאה אטרופיה מוחית.
מה מהנתונים תורם לאבחנה של PROBABLE DEMENTIA DUE TO ALZHEIMER DISEASE ?

א. אטרופיה מוחית שנמצאה ב- CT
ב. אפקט דיכאוני
ג. הפרעה בקשב
ד. החמרה הדרגתית במצב הקוגניטיבי

35. בן 85 עם רקע רפואי של אי ספיקת לב, COPD, סוכרת ויתר לחץ דם מתקבל למחלקה סיעודית. לאחר בירור מול המשפחה ורופא המשפחה – לא ברור האם קיבל חיסון לפנאומוקוק בעברו.
מה ההמלצה לגבי ההתחסנות לפנואומוקוק עבור המטופל?

א. יש להתחסן ב-PCV13 (PREVENAR) בלבד
ב. אם יש ספק בעניין חיסון קודם מותר לתת חיסון חוזר
ג. אין חשיבות לחיסון בגיל 85 באם לא חוסן עד כה
ד. באם סבל מדלקת ריאות ב-5 שנים האחרונות, יש לתת חיסון PCV13 ו-PPSV23

36. בן 78, ברקע PAF, סוכרת, היפרליפידמיה, ומחלת לב איסכמית. התקבל למחלקת שיקום לאחר שהיה מאושפז במחלקה נוירולוגית עקב שבץ מוחי (CVA). בקבלתו לשיקום, הומלץ על טיפול ב- ATORVASTATIN (LIPITOR) במינון גבוה. הפיזיותרפיסט חושש שהטיפול בסטטינים יפגע בשרירים ויפריע לתהליך השיקומי.
מה נכון לגבי מיופתיה על רקע שימוש ב- Lipid lowering agents ?

א. כ- 1% מהמטופלים בסטטינים יכולים לפתח רבדומיוליזיס
ב. רוב המיופתיות מתייצגות תוך חודש מתחילת הטיפול בסטטינים
ג. עליה של CPK נצפית בעד 10% מהמטופלים בסטטינים
ד. טיפול ב- AMIODARONE יכול לעלות סיכון למיופתיה של סטטינים

37. מה נכון לגבי שאלון PHQ-9 לצורך איבחון ומעקב של דיכאון אצל קשישים?

א. תוצאה של 10 ומעלה בשאלון מחשידה ל- MAJOR DEPRESSION

ב. החיסרון בשאלון הוא שאינו כולל הערכת אובדנות

ג. השאלון יעיל לאבחנה, אך אינו רגיש מספיק להערכת יעילות של טיפול

ד. תוצאה של 0-4 בשאלון מצריכה הערכה נוספת

38. בן 84, תשוש בתפקודו, ברקע דמנציה קלה. התקבל למלר"ד עקב חום 38.6, ישנוניות ובלבול. הסטאז'ר הציע לבצע ניקור מותני.

מה ההמלצה לגבי ניקור מותני במטופל ?

א. ברוב המטופלים עם חום ודליריום יש אינדיקציה לביצוע ניקור מותני

ב. יש לבצע ניקור מותני כאשר יש חשד לאנצפליטיס או מנינגיטיס

ג. יש לבצע ניקור מותני אם מופיעים סימנים נוירולוגית פוקליים

ד. דליריום מהווה קונטראינדיקציה לביצוע ניקור מותני עקב סכנה של תזוזה של החולה

39. בן 78 מגיע להערכה עם רעייתו, שמתארת ירידה קוגניטיבית ותפקודית מהירה בחודשים האחרונים: הוא היה מעורב בכמה תאונות קלות, ולאחרונה גם הלך לאיבוד מספר פעמים. בלילות הוא מפריע לה לישון עם דיבור ותנועות תוך כדי שינה, בלילות האחרונים היה משוכנע שנכנסה הביתה קבוצת ילדים, והוא הכין להם שתיה וממתקים. היא מבולבלת כי יש ימים בהם הוא "מתנהג רגיל", "כמו פעם".

אילו ממצאים בבדיקות עזר יעזרו באיבחון המחלה?

א. ממצא ב- EEG של גלים נמוכים ואיטיים באזור הטמפורלי

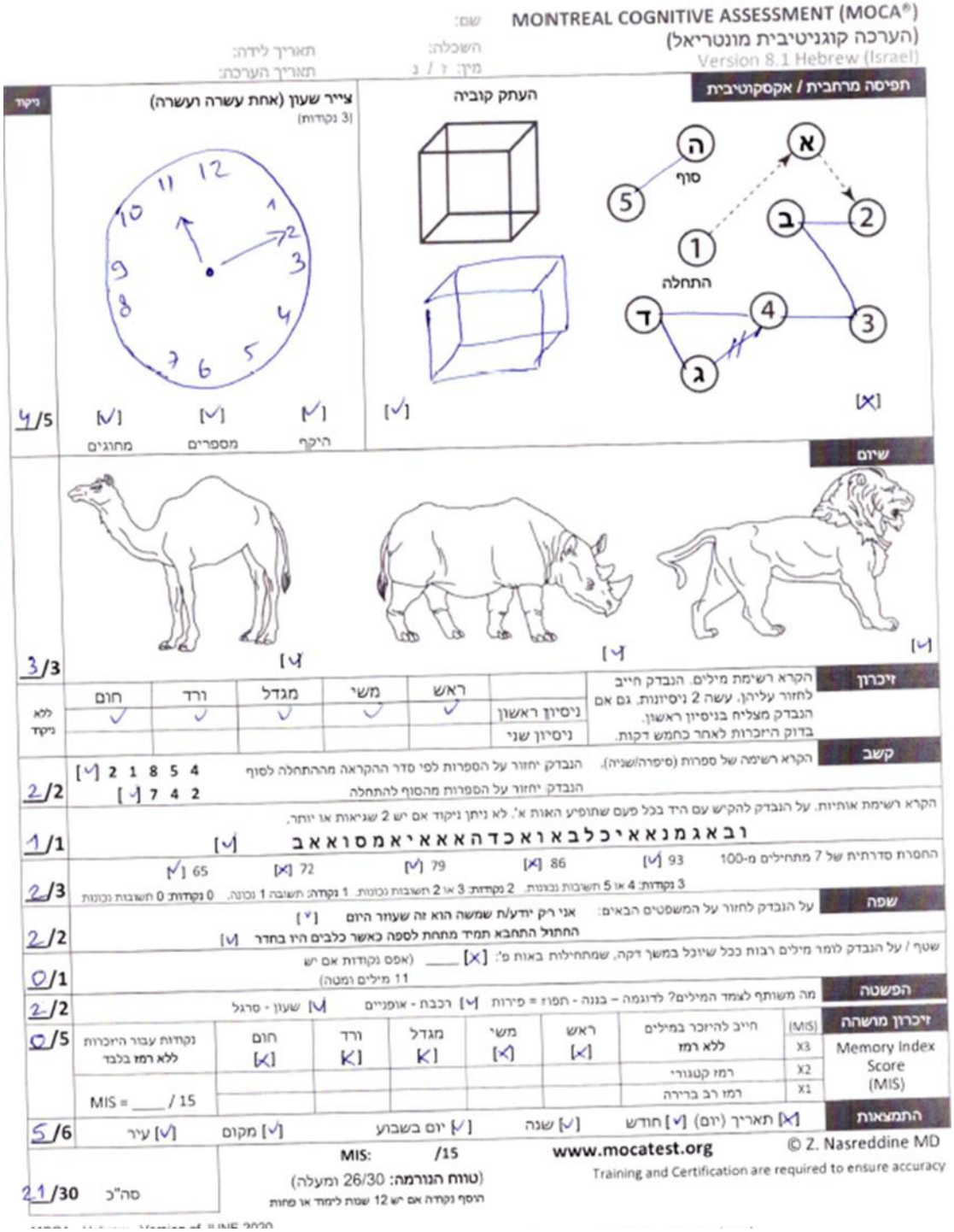
ב. ממצאים אופייניים בניקור מותני

ג. ממצא של ירידת לחץ דם אורתוסטטית

ד. דלדול אונות מדיאליות וטמפורליות ב- MRI

40. בת 78, אקדמאית בהשכלתה, עצמאית בכל התפקודים אובחנה לאחרונה כסובלת ממחלת אלצהיימר בדרגת חומרה קלה. היא מדווחת על הפרעה בעיקר בזיכרון לטווח הקצר אשר מפריעה לה במשחק ברידג' ובניהול כספים.

באבחון הקוגניטיבי שעברה במסגרת הבירור נעשתה בדיקת MOCA המצורפת:



MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MOCA®)
(הערכה קוגניטיבית מונטריאל)
Version 8.1 Hebrew (Israel)

שם:
השכלה:
מין: ז / נ
תאריך לידה:
תאריך הערכה:

תפיסה מרחבית / אקסקוטיבית				ניקוד
העתק קוביה		צייר שעון (אחת עשרה ועשרה) (3 נקודות)		
[✓]	היקף [✓]	מספרים [✓]	מחוגים [✓]	4/5

שיום			
[✓]	[✓]	[✓]	3/3

זיכרון							
הקרא רשימת מילים. הנבדק חייב לחזור עליהן. עשה 2 ניסיונות, גם אם הנבדק מצליח בניסיון ראשון. בדוק היזכרות לאחר כחמש דקות.		ראש	משי	מגדל	ורד	חום	
	ניסיון ראשון	✓	✓	✓	✓	✓	ללא ניקוד
	ניסיון שני						

קשב		
הקרא רשימה של ספרות (סיפרה/שניה).	הנבדק יחזור על הספרות לפי סדר ההקראה מההתחלה לסוף	[✓] 2 1 8 5 4
	הנבדק יחזור על הספרות מהסוף להתחלה	[✓] 7 4 2
		2/2

הקרא רשימת אותיות. על הנבדק להקיש עם היד בכל פעם שתופיע האות א'. לא ניתן ניקוד אם יש 2 שגיאות או יותר.

ו ב א ג מ נ א א י כ ל ב א ו א כ ד ה א א א י א מ ס ו א א ב [✓] 1/1

החסרת סדרתית של 7 מתחילים מ-100 [✓] 93 [✓] 86 [✓] 79 [✗] 72 [✓] 65 2/3

3 נקודות: 4 או 5 חשובות נכונות. 2 נקודות: 3 או 2 חשובות נכונות. 1 נקודה: תשובה 1 נכונה. 0 נקודות: 0 חשובות נכונות

שפה		
על הנבדק לחזור על המשפטים הבאים:	אני רק יודע/ת שמשה הוא זה שעוזר היום	[✓]
	החתול התחבא תמיד מתחת לספה כאשר כלבים היו בחדר	[✓] 2/2

שטף / על הנבדק לומר מילים רבות ככל שיוכל במשך דקה, שמתחילות באות פ': [✗] ____ (אפס נקודות אם יש 11 מילים ומטה) 0/1

הפשטה		
מה משותף לצמד המילים? לדוגמה – בננה - תפוז = פירות	[✓] רכבת - אופניים	[✓] שעון - סרגל 2/2

זיכרון מושהה								
Memory Index Score (MIS)	(MIS)	חייב להיזכר במילים ללא רמז	ראש	משי	מגדל	ורד	חום	נקודות עבור היזכרות ללא רמז בלבד
	x3		[✗]	[✗]	[✗]	[✗]	[✗]	
	x2	רמז קטגוריה						
	x1	רמז רב ברירה						MIS = ____ / 15

0/5

התמצאות				
[✗] תאריך (יום) [✓] חודש	[✓] שנה	[✓] יום בשבוע	[✓] מקום	[✓] עיר 5/6

MIS: /15
(טווח הנורמה: 26/30 ומעלה)
הוסף נקודה אם יש 12 שנות לימוד או פחות

סה"כ 21/30

www.mocatest.org
© Z. Nasreddine MD
Training and Certification are required to ensure accuracy

המשך שאלה 40-

המטופלת ובעלה מבקשים לדעת האם מומלץ לבצע תרגול קוגניטיבי ומאיזה סוג. מהי ההמלצה הנכונה?

א. מומלץ לבצע תרגול קוגניטיבי בתחומים שהיו לקויים באבחון כמו הזיכרון והריכוז

ב. מומלץ לבצע תרגול קוגניטיבי בתחומים שנמצאו שמורים באבחון, לדוגמא בתחום השפתי ובתחום התפיסה החזותית מרחבית

ג. מומלץ להימנע מתרגול קוגניטיבי מאחר ואינו יעל והוא עשוי להוביל לתסכול ולדיכאון

ד. מומלץ להמשיך ולהשתתף בפעילות לגירוי קוגניטיבי לצורך עניין והנאה בלבד

41. בן 92 הסובל מדמנציה מתקדמת, מאושפז מזה חודש במחלקת קורונה. בקבלתו המוגלובין 12.8. במהלך האשפוז הופיעו פצעי לחץ דרגה 4 בשני הטרוכנטרים. כעת סובל גם מ- MRSA SEPSIS.

בבדיקות המעבדה:

מדד ויחידות	המטופל	ערכים תקינים
WBC 10e3qµL	12,800	4.0-11.0
HgB gr/dl	9.5	13.2-17
MCV fL	80	80-96
PLT 10e3qµL	496,000	140-450
NEU %	82	40-75
LYM %	16	20-40
IRON µg/dL	32	40-150
TRANSFERRIN mg/dL	152	220-400
FERRITIN ng/dL	188	14-163
VIT B12 pg/mL	>1000	175-961
FOLIC ACID ng/mL	3.6	2.6-17
BUN mg/dL	24	5-25
CREATININE mg/dL	0.5	0.7-1.3
ALBUMIN g/L	26	35-50
CRP mg/L	158	0.03-5.0

מה האבחנה והטיפול המומלץ לאנמיה?

א. מדובר קרוב לודאי ב- MYELOSYSPLASTIC SYNDROME ומומלץ לתת טיפול ב- ERTHROPOIETIN

ב. מדובר באנמיה מחסר ברזל ומומלץ טיפול בברזל תוך ורידי

ג. לא ניתן לאבחן את סוג האנמיה ללא בדיקת מח עצם ולכן לא ניתן להמליץ על טיפול

ד. מדובר באנמיה של מחלה כרונית. רק שיפור במצבו הזיהומי ישפר את האנמיה

42. כשליש מהחולים הסובלים מדמנציה בשלב מתקדם מפתחים הפרעות בליעה. לפי המלצות "COOSING WISEWLY" של האיגוד הגריאטרי האמריקאי, מה היתרונות/ חסרונות של "הזנת צינור" מול הזנה פומית?

א. הזנת צינור בחולים עם דמנציה מתקדמת מביאה לשיפור ניכר במצב התזונתי

ב. הזנת צינור מצריכה לעתים שימוש בהגבלה כימית או פיזית של המטופל

ג. הזנת צינור מפחיתה את הסיכון להתפתחות פצעי לחץ

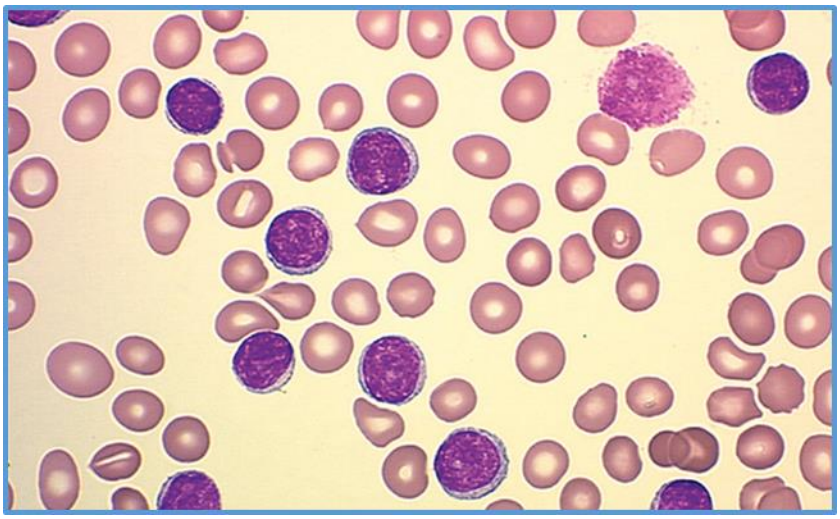
ד. בהזנת צינור, בהשוואה להזנה פומית, שיעור נמוך יותר של דלקת ריאות הנובעות מאספירציה

43. בן 86, בריא בדרך כלל, שמור קוגניטיבית. לא היה אצל רופאת המשפחה ב- 5 השנים האחרונות ולא עשה בדיקות דם. הגיע למחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון) לאחר נפילה ברחוב. בדיקה גופנית ללא ממצא משמעותי. לחץ הדם שמור, ללא חום. בדיקה גופנית תקינה ואין עדות לשבר או חבלת ראש.

בספירת הדם:

מדד ויחידות	המטופל	ערכים תקינים
WBC 10e3qµL	31.2	4.0-11.0
HgB gr/dl	14.5	13.2-17
PLT 10e3qµL	231	140-450
NEU %	11	40-75
LYM %	85	20-40

במשטח דם:



המטופל מתמצא בסיטואציה, במקום ובזמן, ללא חסר קוגניטיבי בולט ומעוניין להשתחרר לביתו.

מה ההמלצה הטיפולית לגבי הממצא בספירת הדם?

א. אשפוז עם טיפול אנטיביוטי רחב טווח בחשד ל- SEPSIS

ב. אשפוז לצורך בדיקת מח עצם בחשד ל- ACUTE LEUKEMIA

ג. שחרור למעקב מרפאה המטולוגית בחשד ל- CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

ד. שחרור עם המלצה לטיפול ב- G-CSF עקב נויטרופניה אסימפטומטית ומעקב מרפאה המטולוגית בהקדם

44. בן 90, במעקבך מזה כ-5 שנים בשל ירידה קוגניטיבית קלה. בנוסף סובל מאי ספיקה כלייתית עם פינוי קריאטינין של 35 מ"ל/דקה. עקב כאבי גב כרוניים מטופל ב- ZALDIAR (TRAMADOL+PRACETAMOL). בביקורת האחרונה היה עצוב, הרבה לבכות והביע מחשבות של חוסר ערך וחוסר תקווה.

מהו שיקול נכון לגבי הטיפול בדיכאון במטופל זה?

א. אי ספיקה כלייתית מהווה קונטראינדיקציה למתן MIRTAZAPINE (MIRO)

ב. טיפול ב- SSRI's בקשישים כרוך בסיכון מוגבר להתאבדות

ג. טיפול ב- Venlafaxine בשילוב עם Tramadol יכול לגרום ל- Serotonin Syndrome

ד. התועלת של פסיכותרפיה בזקנים עם דיכאון אינה משמעותית

45. בן 66, מהנדס במפעל, הגיע למיון בבית חולים פסיכיאטרי. בני המשפחה מספרים על שינוי באישיות מזה כשנה: קשריו החברתיים התקלקלו בשל אירועים חוזרים של התנהגות לא הולמת בציבור – מקלל ומעיר הערות סקסיסטיות ופוגעניות, עלה כ-20 ק"ג במהלך השנה תוך אכילה בלתי פוסקת של דברי מתיקה. לאחרונה ניכרת גם ירידה תפקודית – לא מצליח לבצע את עבודתו, מתקשה גם בבישול.

בבדיקה: אפקט מרומם, לא תואם. MMSE=29/30.

מה ההמלצה הטיפולית?

א. טיפול ב-SSRI's

ב. טיפול במעכבי כולינאסטרז

ג. טיפול באנטי פסיכוטים אטיפיים

ד. בגילו ובנוכחות MMSE תקין - מדובר בהפרעה פסיכיאטרית שאינה קשורה לגריאטריה

46. בת 65, גרה בבית, עצמאית ב- BADL וללא חסר קוגניטיבי. רקע רפואי של סוכרת (A1C אחרון של 7.4) ויתר לחץ דם. בגין תלונות על צריבה במתן שתן פונה למרפאה. סטיק שתן חיובי ללויקוציטים וניטריטים.

אלו מבין הבאים מתאים כקו ראשון לטיפול אנטיביוטי?

א. CIPROFLOXACIN למשך 7 ימים

ב. NITROFURANTOIN (מקרודנטין) למשך 5 ימים

ג. TRIMETOPRIM/SULPHAMETHOXAZOLE (רספרים) 7 ימים

ד. PHOSPHOMYCIN (מונורול) למשך 3 ימים

47. למי מהמטופלים הבאים יש להמליץ על החלפת מסתם אאורטלי (לכולם תפקוד חדר שמאל תקין)?

חולה	פרטים רפואיים	שטח מסתם אאוטרלי	מהירות זרימה מעל המסתם	מפל ממוצע
א.	בן 82, מזה 3 חודשים תעוקת חזה במאמץ	0.9 סמ"ר	4.5 מ/ש	20 ממ"כ
ב.	בן 79, מועמד לניתוח מעקפים אלקטיבי	1.7 סמ"ר	2.8 מ/ש	20 ממ"כ
ג.	בן 69, עם אירועים חוזרים של התעלפות	1.6 סמ"ר	2.5 מ/ש	24 ממ"כ
ד.	בן 80, מתהלך עם מקל, אסימפטומטי	0.8 סמ"ר	4.5 מ/ש	50 ממ"כ

48. בת 75, דיירת במחלקה לתשושים הסובלת מדמנציה קלה ואירועי חרדה ברקע, מדווחת על דאגה מתמדת. הצוות המטפל בה מדווח כי היא מתקשה להתמקד ושהיא סובלת מנדודי שינה עם שיטוט מוגבר במהלך היום והלילה. היא השתתפה בטיפול קבוצתי במשך 6 השבועות האחרונים עם שיפור מינימלי. לא מטופלת תרופתית כרגע.

מה הטיפול התרופתי המתאים למטופלת בקו הראשון?

א. Donepezil (Memorit)

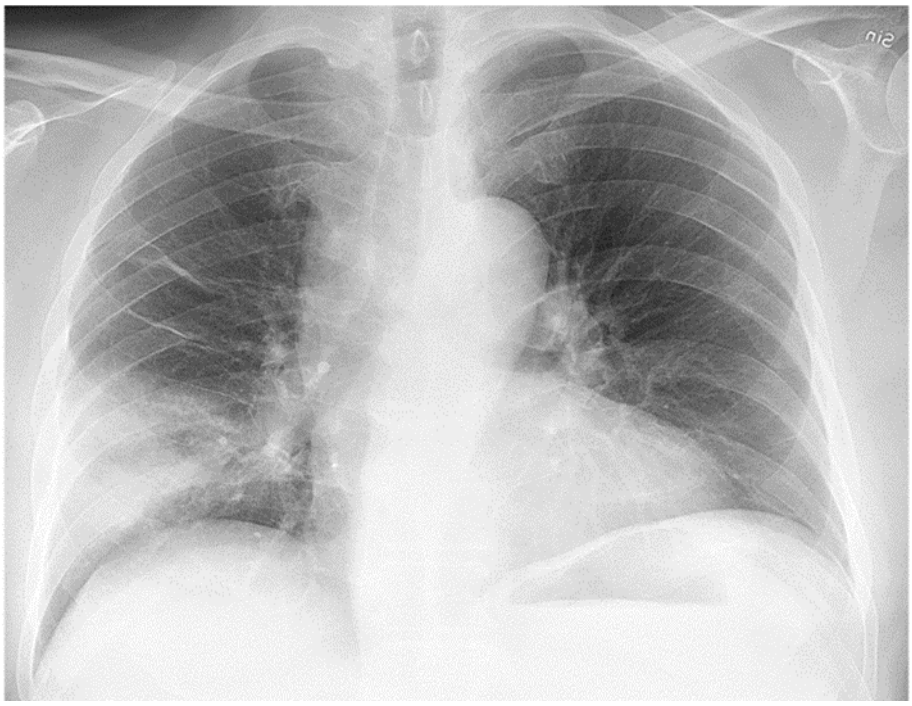
ב. Citralopam (Cipramil)

ג. Oxazepam (Vaben)

ד. Quetiapine (Seroquel)

49. בן 85, התקבל למחלקה לרפואה דחופה עקב חום, שיעול פרודוקטיבי וחולשה כללית. בבדיקתו חום 38.5 ,ל"ד 80/50 mm Hg ,מבולבל, 30 נשימות לדקה, קריאטינין 2.5 BUN=45 מ"ג/ד"ל.

בצילום חזה:



מה הסיכון לתמותה אצל המטופל ?

א. פחות מ- 5%

ב. 5%-10%

ג. 20%

ד. מעל 40%

50. בת 85, ברקע יל"ד וסוכרת, התקבלה עם שבץ מוחי שהתבטא בהמיפלגיה של צד שמאל. לאחר אשפוז בנוירולוגיה, הגיעה לשיקום. כשבוע לאחר אשפוזה, התחילה להתלונן על כאבים באזור הכתף השמאלית. הועלתה השערה שמדובר ב"כאב כתף המיפלגית" - hemiplegic shoulder pain.

מה הטיפול המתאים למצב זה?

א. הטיפול כולל מתלה תומך למניעת תת-פריקה ותרגולים למניעת קונטרקטורות

ב. מדובר ברוב המקרים בכאב ממקור מרכזי ולכן טיפול ב- PREGABALIN ((LYRICA יכול לעזור

ג. אם לא משתפר ספונטנית לאחר חצי שנה, יש מקום לטיפול בגירוי חשמלי מקומי

ד. מומלץ להפחית את אינטנסיביות הטיפול השיקומי עד להפחתת הכאב

51. בת 94, גרה לבדה עד האשפוז, לא ידוע על ירידה קוגניטיבית. מאושפזת במחלקה פנימית בשל אלח דם (SEPSIS) ממקור של דלקת בדרכי השתן. היא נושאת קתטר שתן ומטופלת באנטיביוטיקה דרך הוריד. רופא גריאטר נקרא לתת יעוץ בשל מצב של אי-שקט ובלבול. בבדיקה נראית כאובה, סובלת מאי שקט פסיכו-מוטורי בולט, ליקוי בקשב, חוסר התמצאות במקום ובזמן.

רשימת תרופות שמקבלת:

ROCEPHIN

(CLEXAN) ENOXAPARIN

PARACETAMOL

(VABEN) OXAZEPAM

(TRITACE) RAMIPRIL

(SPASMEX) TROSPIUM

(BONDORMIN) BROTIZOLAM

מה צריך לייעץ בהתייחס לטיפול התרופתי שהמטופלת מקבלת?

א. להפסיק טיפול ב- VABEN שקיבלה בביתה

ב. להפסיק את הטיפול ב- TROSPIUM (SPSMEX)

ג. להחליף את ה-BROTIZOLAM (BONDORMIN) ב- ZOLPIDEM (ZODORM)

ד. להוסיף טיפול קבוע ב- TRAMADOL לאיזון כאב

52. לעיתים נדרשת אבחנה מבדלת בין דליריום, דמנציה, דיכאון ופסיכוזה.

מה נכון בנוגע להשוואה בין האבחנות השונות?

א. גם בדליריום וגם בדמנציה ההופעה היא הדרגתית

ב. הלוצינציות ראיה אופייניות לדליריום ולדיכאון

ג. רק בדליריום ניתן לראות שינוי במצב ההכרה

ד. בכולם יש הפרעה בזיכרון

53. בת 67 מגיעה לייעוץ לגבי גורמים להאטת הזדקנות המוח.

מה נכון להמליץ לה?

א. פעילות גופנית מפחיתה איבוד נפח מוחי ומשפרת נוירוגנזה

ב. פעילות אינטלקטואלית ופעילויות פנאי מחוץ לבית טובות להפגת בדידות אך אינן רלבנטיות לשימור תפקודי המוח

ג. דיאטה עתירת חלבון משפרת את בריאות המוח

ד. איזון קפדני של מחלות כמו היפרליפידמיה, סכרת, ויתר ל"ד ימנע מוות לבבי, אך אינו קשור למניעת דמנציה

54. בן 73, מגיע למרפאה גריאטרית בשל חוסר יציבות, חולשה כללית, ונפילות חוזרות. הוא מתאר קצב הליכה איטי, מתלונן על דחיפות במתן שתן ומספר שהוא קם לשירותים 3-4 פעמים בלילה. שולל בעיות זיכרון, הזיות או מחשבות שוואה. רופא המשפחה ניסה טיפול ב- DOPICAR לכמה חודשים ללא שיפור משמעותי.

בבדיקה- לחץ דם בשכיבה 156/84, אך יורד ל- 104/73 סיסטולי בעמידה, דופק כ- 95. מתנייד עם הליכון, הליכה shuffling gait, תנועות רגליים ללא קואורדינציה טובה, כיפוף גב קדימה, ללא רעד במנוחה, אבל רעד בביצוע תנועה מכוונת, תנועות עיניים תקינות. בהערכה קוגניטיבית MMSE – 29/30, MRI של המוח ללא הרחבת חדרים או גרורות.

איזו מהאבחנות הבאות היא הסבירה ביותר?

א. מחלת פרקינסון

ב. Lewy Body Disease

ג. Progressive supranuclear palsy

ד. Multisystem Atrophy

55. בת 81, הולכת עם מקל מאז ניתוח החלפת ברך. ברקע יתר ל"ד. נוטלת LERCANIDIPINE (VASODIP) . אושפזה במחלקה קרדיולוגית בעקבות NSTEMI שטופל באמצעות צנתור שכלל הנחת תומכן. אקו לב הדגים תפקוד סיסטולי מעט ירוד של חדר שמאל (LVEF 45%). כעת מיועדת לשחרור לביתה. סימנים חיוניים שנלקחו יום לפני השחרור - ל"ד 125/82, דופק 59 ובבוקר השחרור – ל"ד 116/80, דופק 58.

בשחרור הומלץ על טיפול ב- ASPIRIN, (CLOPIDOGREL) PLAVIX ו- ATORVASTATIN (LIPITOR).

איזו מבין רשימות תרופות הבאות מתאימה להשלמת התרופות המומלצות בשחרור:

א. LERCANIDIPINE (VASODIP), BISOPROLOL (CARDILOC)

ב. LERCANIDIPINE (VASODIP) , RAMIPRIL (TRITACE)

ג. RAMIPRIL (TRITACE)

ד. BISOPROLOL (CARDILOC)

56. בן 85, סובל מקושי להירדם. מתעניין לגבי אפשרות לשימוש בתרופות ממשפחת Non benzodiazepines drugs (Z-drugs) .

מה היתרון של שימוש בתרופות אלו על פי ההמלצות של POCKET GUIDE TO THE 2019 AGS BEERS CRITERIA?

א. גורמות לפחות נפילות ושברים לעומת בנזודיאזיפינים

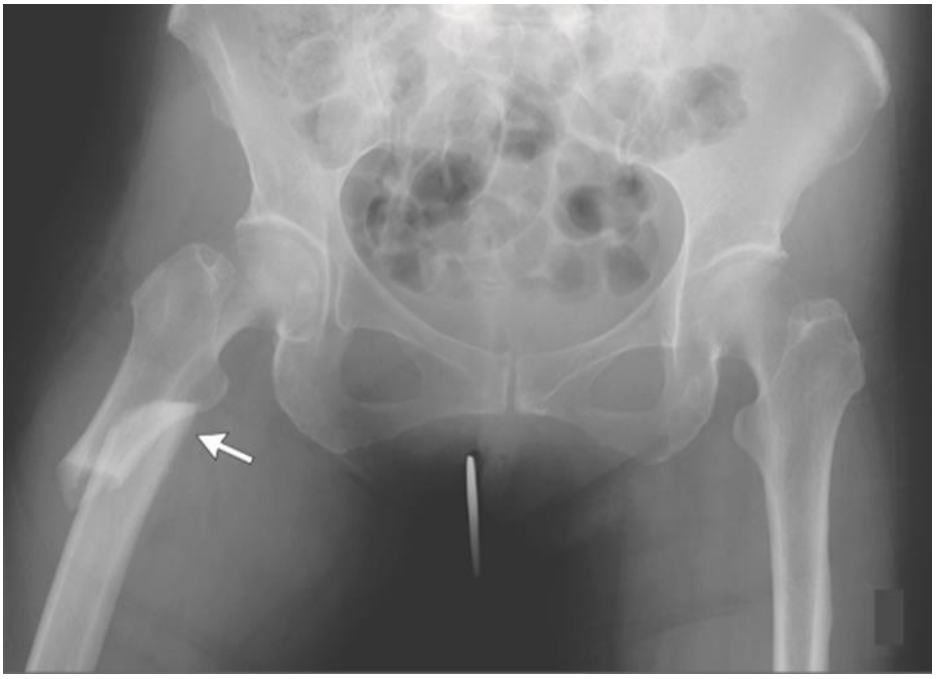
ב. מפחיתות סיכוי לדליריום

ג. מקצרות מעט את הזמן שלוקח להירדם

ד. ההשפעה שלהם טובה מאוד לגבי משך השינה

57. בן 74, תשוש בתפקודו. התקבל למחלקה לרפואה דחופה לאחר נפילה.

מה הניתוח המומלץ לשבר שבתמונה על פי המאמרManagement of Acute Hip Fracture מאת Bhandari וחבריו?



א. קיבוע פנימי (internal fixation) על ידי ברגים

ב. מסמור תוך לשדי (intramedullary nails)

ג. החלפת מפרק ירך (arthroplasty)

ד. קיבוע פנימי (internal fixation) על ידי sliding hip screw

58. בן 75, עצמאי ב- BADL. ברקע - סכרת ואי ספיקת לב, מטופל ב- DAPAGLIFUZIN (FORXIGA), LINAGLIPTIN (TRAJENTA), METFORMIN , ENALAPRIL ו- DISOTHIAZIDE. התקבל לאשפוז אלקטיבי לניתוח TKR שבוצע ללא אירועים חריגים. ביממה השנייה לאחר הניתוח חלה ירידה במצב ההכרה, החולה נמצא ישנוני ומבולבל. ל"ד 90/60 דופק 100 סדיר, סטורציה תקינה, חום תקין.
במעבדה:

בדיקה ויחידות	ערך לחולה	ערכי נורמה
BUN mg/dL	80	5-25
CREATININE mg/dL	1.7	0.6-1.1
NA mmol/L	145	135-146
K mmol/L	4.5	3.5-5.3
Cl mmol/L	88	95-110
PH	7.0	7.35-7.45
PCO2 mmHg	35	35-46
HCO3 mmol/L	14	21-26

בבדיקת שתן: לויקוציטים + , תאים אדומים -, ניטריט -, קטונים +++
תופעת לוואי של איזו מהתרופות הבאות עשויה להיות הגורם למצבו של החולה?

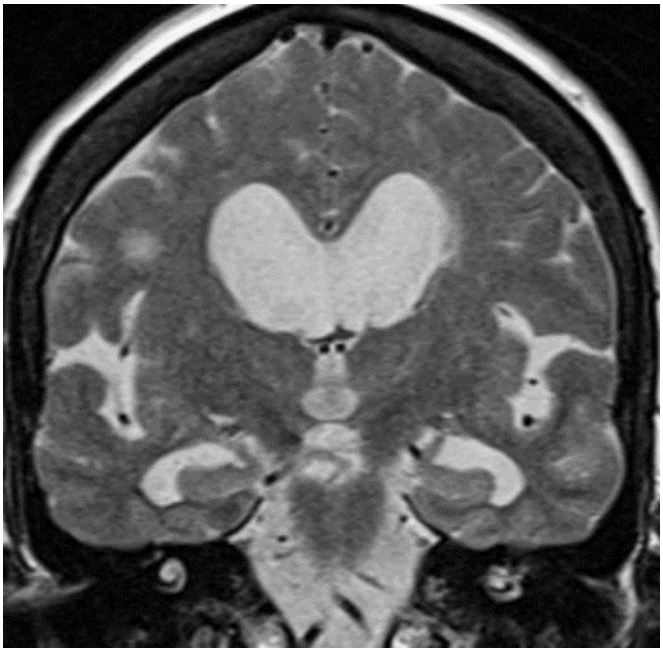
א. METFORMIN
ב. DAPAGLIFLOZIN (FORXIGA)
ג. LINAGLIPTINE (TRAJENTA)
ד. DISOTHIAZIDE

59. מה מאפיין כאב גב מותני בחולים הסובלים מהיצרות ספינאלית?

א. הכאב מחמיר במעבר משכיבה לישיבה
ב. הכאב מחמיר בהליכה בעליה
ג. הכאב מחמיר בהרמה של חפצים כבדים
ד. הכאב מחמיר בשכיבה על הגב

60. בן 75, הופנה על ידי רופא המשפחה לביצוע בדיקת הדמיה (MRI) במסגרת בירור ירידה קוגניטיבית הדרגתית ומתמדת במהלך השנה האחרונה. ברקע – יתר לחץ דם, סוכרת מסוג 2, ניתוח תיקון שבר בירך שמאל לפני כשנה ושבר ביד ימין לאחר נפילה לפני חודשיים. אשתו מדווחת על הפרעות שליטה על סוגר השתן מאז הנפילה והשבר בירך שמאל.

בבדיקת MRI :



מה הטיפול האפשרי למטופל זה?

א. DOPICAR

ב. RIVASTIGMINE (EXELON)

ג. ניתוח VENTRICULO-PRITONEAL SHANT

ד. קרינה לאזור הפריאטלי מימין

61. בת 79, ברקע סוכרת קלה ויתר לחץ דם , מתעניינת במתן ייפוי כוח לבנה.
איזה מהבאים נכון בנוגע לאפשרות לחתום על ייפוי כוח?

א. אין לה אפשרות לחתום על ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות כיוון שאינה מוגדרת כעת כזו.

ב. יש באפשרותה לחתום על ייפוי כוח מתמשך רפואי בפני עו"ס

ג. יש באפשרותה לחתום על ייפוי כוח מתמשך מלא בפני רופא

ד. יש באפשרותה לחתום על ייפוי כוח מתמשך רפואי רק בפני עורך דין

62. בת 82, עצמאית ב- BADL וללא חסר קוגניטיבי. סובלת מסוכרת בשנים האחרונות. ברקע ידוע על אי ספיקת כליות קלה. המטופלת מעוניינת לדעת אילו ערכים מומלצים לה לפי הקווים המנחים, שפורסמו לאחרונה (מאמר SDANDARTS OF MEDICAL CARE 2020).

א. גלוקוז בצום עד 150, איזון לחצי דם של 140/80, HBA1C של מתחת ל- 7.5

ב. גלוקוז בצום עד 180, איזון לחצי דם של 150/90, HBA1C של מתחת ל- 8.5

ג. גלוקוז בצום עד 100, איזון לחצי דם של 120/80, HBA1C של מתחת ל- 7

ד. גלוקוז בצום עד 130, איזון לחצי דם של 140/90, HBA1C של מתחת ל- 7.5

63. בן 75, ברקע - מחלת לב איסכמית, MI לפני כ-5 שנים, מטופל ב - ASPIRIN. התקבל לאשפוז בעקבות דלקת ריאות. במהלך האשפוז, בעקבות פרפור פרוזדורים עם תגובה חדרית של 120, טופל בחוסמי ביטא וחזר לקצב סינוס. המטופל במשקל 70 ק"ג, בד"כ נייד בבית, נפל לפני כחצי שנה בביתו בעקבות היתקלות בשטיח, תפקודי כליה תקינים.

מהו הטיפול התרופתי המומלץ בשחרורו?

א. הוספת טיפול ב- APIXABAN 2.5mg (ELIQUIS) פעמיים ביום

ב. הפסקת טיפול ב-ASPIRIN והתחלת טיפול ב-APIXABAN 5mg (ELIQUIS) פעמיים ביום

ג. הוספת טיפול ב-RIVAROXABAN 15mg (XARELTO) פעם ביום

ד. המשך טיפול ב ASPIRIN בלבד

64. בן 68, חולה דיאליזה הסובל מקרצינומה של הריאה הוגדר על ידי האונקולוג כחולה הנוטה למות. הוא ללא חסר קוגניטיבי והוגדר כשיר לקבל החלטות. לאחרונה הביע רצונו שלא להאריך את חייו באמצעים מלאכותיים לרבות הפסקת טיפולי הדיאליזה.

איזה מהבאים נכון בנוגע לתגובה הנדרשת לבקשתו של החולה?

א. יש להימנע מלשבץ את החולה לטיפולי דיאליזה ולהנחות אותו כיצד לטפל בתופעות הצפויות

ב. לא ניתן להפסיק טיפולי דיאליזה היות ומדובר בטיפול רציף

ג. לא ניתן לקיים את רצונו של החולה מבלי שמילא הנחיות מקדימות מפורטות בנוגע לטיפולי הדיאליזה

ד. בחולה שהוגדר על ידי אונקולוג כחולה הנוטה למות ניתן להפסיק טיפול בדיאליזה גם ללא בקשת החולה

65. בת 79, ברקע סוכרת מאוזנת והיפותירואידיזם, הופנתה על ידי רופא המשפחה לצורך המלצה בנוגע לטיפול תרופתי בדיכאון. הדיכאון אובחן לפני כחצי שנה ומאז קיבלה SERTRALINE (LUSTRAL) במינון של 50 מ"ג ליום, ללא הטבה בדיכאון ב- . נשללו בעיות רפואיות אחרות, מעבדה תקינה. קיימת היענות טובה לטיפול ואין למטופלת תופעות לוואי.

מה ההמלצה להמשך הטיפול?

א. מאחר והחולה לא הגיבה לטיפול ב-SERTRALINE (LUSTRAL), מומלץ לשנות לתרופה חלופית מאותה הקבוצה (SSRI), כגון ESCITALOPRAM (CIPRALEX)

ב. נוכח סבילות טובה לטיפול, מומלץ להמשיך בו ולהוסיף טיפול בתרופה מקבוצה אחרת כגון SNRI

ג. מומלץ להעלות מינון של SERTRALINE (LUSTRAL) בהדרגה ל-100 מ"ג ביום ולבחון מחדש תועלת הטיפול מספר שבועות לאחר הגעה למינון זה

ד. מומלץ ללכת במקביל לטיפול פסיכולוגי שכן הסבירות להשגת שיפור עם טיפול תרופתי בלבד הינה נמוכה

66. באיזה מהמצבים הבאים יופעל מיופה כוח של אדם שחתם על ייפוי כוח מתמשך רפואי?

א. בת 76, שהוכרזה כחולה נוטה למות וזקוקה להקרנות כעת

ב. בן 94, המגיע לניתוח החלפת מפרק ירך אלקטיבי ומבין את השלכות הניתוח

ג. בת 72, הסובלת מאלח דם (SEPSIS) ודליריום וכעת צריכה להסכים לכריתת כיס מרה דחופה

ד. בן 80, כבד שמיעה, ששכח את מכשירי השמיעה בבית וכעת צריך להסכים לניתוח קיבוע שבר

67. בת 78, מאושפזת במחלקה לסיעוד מורכב עקב פצעי לחץ מרובים.

איזו מההתערבויות התזונתיות הבאות הוכחה כמשפרת ריפוי פצעי לחץ באופן משמעותי?

א. תוספת טיפול בויטמינים A,E,D ו-K

ב. כלכלה פומית עשירת אנרגיה וחלבון

ג. תוספת אבץ וויטמינים מקבוצה B

ד. כלכלה אנטרלית בזונדה

68. מה אופייני בבדיקה פיסיקלית של מטופל עם אי-ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור (HFPEF)?

א. ל"ד מאוזן

ב. גודש ורידי צוואר

ג. בהאזנה ללב קול רביעי

ד. הסטה של הולם הלב

69. בן 84, סובל שנים רבות מ-COPD (CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE), הגיע למרפאה לצורך הערכה גריאטרית כוללנית.

באבחון נמצא MMSE - 23/30, GDS - 8/15, BMI - 28 , TIMED UP AND GO - 15 שניות.

אילו מהממצאים באבחון הגריאטרי דורשים התייחסות בקשר למחלת הריאות?

א. עקב BMI 28 מומלץ לפנות לתזונאי/ת לירידה במשקל

ב. עקב MMSE 23 יתכן ולא משתמש במשאפים בצורה נכונה

ג. עקב GDS-8 יש הגבלה בטיפול תרופתי שיכול לקבל לדיכאון

ד. עקב מבחן GET UP AND GO פתולוגי <u>לא</u> יצליח ליהנות משיקום נשימתי

70. בן 88, סובל מדמנציה מתקדמת והוגדר כחולה נוטה למות על רקע מחלה זו. לאחרונה הוא אוכל מעט והצוות במחלקה הסיעודית שבה מטופל העלה אפשרות של "הזנת צינור". הוא לא השאיר הנחיות מקדימות או ייפוי כוח רפואי.

מה האפשרויות החוקיות במצב זה (לפי המלצות ועד המותב)?

א. הארכת חיים מלאכותית בחולה נוטה למות הינה מנוגדת עקרונית לחוק ולכן לא מומלץ להאכיל בזונדה או PEG

ב. הדרך המועדפת להאכלה של חולים עם דמנציה סופנית הינה ב- PEG

ג. בחולה דמנציה המוגדר כחולה הנוטה למות מותר להמשיך הזנה פומית (COMFORT FEEDING) ובמידת הצורך תוספת עירוי נוזלים

ד. כדאי לדחות את התקנת ה PEG כמה שאפשר ולהשתמש בינתיים בזונדה, שכן פרוצדורת החדרת ה PEG הינה מורכבת

71. בן 88, מובא למחלקה לרפואה דחופה לאחר שנמצא בביתו בהכרה מעורפלת. ידוע על ירידה קוגניטיבית, עליה במשקל והחמרה באי ספיקת לב בחודשים האחרונים. ברקע - ידוע על תת תריסיות. בבדיקה במערכת "אופק" מתגלה כי לא רכש Levothyroxine בשמונת החודשים האחרונים. בבדיקה: בהכרה מעורפלת,, קצב לב 38 פעימות לדקה, ל"ד 85/48, טמפרטורה 34.2, סטורציה 89% באוויר חדר.

כיצד יש להתחיל את הטיפול במטופל זה?

א. הטיפול הראשוני יכלול גם טיפול ב- Hydrocortisone

ב. המתנה לתשובת בדיקות הדם לפני התחלת הטיפול ב- Levothyroxine

ג. מתן טיפול ב - T3 תוך ורידי

ד. התחלת טיפול במינון נמוך של levothyroxine, 50 מק"ג

72. בת 73, מגיעה למיון עקב קוצר נשימה. היא מתארת החמרה במצבה בחודש האחרון, עם קוצר נשימה, ירידה תפקודית, וסחרחורת במאמץ מינימאלי מזה כשבוע. אושפזה בחצי שנה האחרונה 6 פעמים עקב קוצר נשימה, כאבים בחזה ובצקות פריפריות. ברקע - מחלת לב איסכמית, מחלת כלי דם היקפיים, היצרות עורק כלייתי, סוכרת. עברה ניתוח מעקפים לפני כ- 10 שנים, וצנתור אחרון במשך אשפוזה האחרון עם התערבות למעקפים ופתיחתם, כמו כן הושתל סטנט לעורק כלייתי המוצר. בבדיקה- לחץ דם 110/70, דופק 130, נשימות 24, מעבדה- BUN 23, קריאטינין 1.5 בהחמרה מבסיס. אקוקרדיוגרפיה הראתה חדר שמאל מורחב עם מקטע פליטה 20% ואי ספיקה מיטראלית קלה.

איזו מההתערבויות הבאות יכולה לשפר את איכות חייה ולהאריך אותם?

א. השתלת לב

ב. מכשיר תומך בחדר שמאל Left ventricular assisted device

ג. הזלפת תכשירים אינוטרופיים כגון DOBUTAMINE או MILRINONE

ד. אין מה שיכול לשפר את מצבה, יש להעבירה לטיפול פליאטיבי בלבד

73. הממשלה מעוניינת לבדוק כדאיות חיסון לקורונה בקרב אנשים בני פחות מ- 60 שגרים עם קשישים באותו בית.

על פי הפרסום "בני +65 בישראל" מה אחוז הקשישים שגר עם ילדיו בבית?

א. 0.5% מהקשישים גרים במשק בית של זוג עם ילדים, 0.5% גרים במשק בית של הורה יחיד עם ילדים

ב. 2% מהקשישים גרים במשק בית של זוג עם ילדים, 1% גרים במשק בית של הורה יחיד עם ילדים

ג. 12% מהקשישים גרים במשק בית של זוג עם ילדים, 5% גרים במשק בית של הורה יחיד עם ילדים

ד. 24% מהקשישים גרים במשק בית של זוג עם ילדים, 12% גרים במשק בית של הורה יחיד עם ילדים

74. בת 82, מאושפזת מזה כשבועיים בטיפול נמרץ באבחנה של דלקת ריאות, כשהיא מונשמת ומטופלת באנטיביוטיקה וסטרואידים IV. תחת הטיפול נצפה שיפור קליני במצבה. בשל הופעת פרפור עליות במהלך האשפוז נלקחה בדיקה לתפקודי בלוטת התריס. להלן התוצאות.

מדד ויחידות	ערך לחולה	ערכי נורמה
TSH mU/L	<0.01	0.4-4.7
T4 ng/dl	<0.1	0.7-1.8
T3 pg/ml	<0.01	1.71-3.71

מה ההסבר לשינוי בבדיקות וההמלצה הטיפולית?

א. מדובר בהיפותירואידזם מרכזי, יש להשלים בדיקות מעבדה לשלול מחלה היפופיזרית נוספת, ולהתחיל בהקדם טיפול ב- IV LEVOTHROXIN

ב. מדובר ב-Non thyroidal illness syndrome ויש להתחיל טיפול ב- IV LEVOTHYROXINE

ג. היות ובמצב זה תיתכן גם פגיעה באדרנל המשך טיפול בסטרואידים יתרום לעליה ב- TSH

ד. אין השלכה קלינית לתוצאות בשלב זה, יש להמליץ על בדיקה חוזרת לתפקודי תריס בעוד כחודשיים

75. ועדת אתיקה ארצית החליטה על תיעדוף הנשמה של מטופלים הסובלים מ- SARS COVID 19 במקרה של חסר במכונות הנשמה.

על פי המאמר Israel Ad Hoc COVID-19 Committee: Guidelines for Care of Older During a Persons Pandemic על פי איזה קריטריונים הוחלט לתעדף מטופלים?

א. גיל כרונולוגי, שבריריות, תפקוד

ב. גיל ביולוגי, תפקוד, תחלואה

ג. גיל כרונולוגי, אשפוזים חוזרים, נכות

ד. גיל ביולוגי, קוגניציה, תפקוד

76. בגיל המבוגר מתרחשים שינויים הורמונליים המעלים סיכון להתייבשות. איזה מהבאים מתאר נכונה שינויים אלה?

א. רמת ALDOSTERONE גבוהה וקיימת תגובה מוגברת ל ADH בכליות

ב. רמת ALDOSTERONE גבוהה וקיימת תגובה ירודה ל ADH בכליות

ג. רמת ALDOSTERONE נמוכה וקיימת תגובה מוגברת ל ADH בכליות

ד. רמת ALDOSTERONE נמוכה וקיימת תגובה ירודה ל ADH בכליות

77. איזה מהבאים מאפיין מטופל המאובחן כסובל מ Mild cognitive impairment (MCI) ?

א. מתפקד באופן עצמאי אך עלול להזדקק לעזרה בפעולות מורכבות, כמו ניווט למקומות לא מוכרים

ב. סובל מהפרעה בזיכרון לטווח קצר ללא פגיעה בשאר התפקודים הקוגניטיביים

ג. תפקודו הקוגניטיבי לא יכול להשתפר

ד. קיימת חוסר מודעות להפרעה הקוגניטיבית

78. בת 78, פנתה למרפאה עקב חולשה וירידה במשקל של 5 ק"ג בשנה האחרונה. בן זוגה מדווח על ירידה מסויימת בזיכרון. לחץ הדם 128/62 עם ירידה ל- 102/45 בעמידה.

בבדיקות המעבדה:

בדיקה ויחידות	ערך לחולה	ערכי נורמה
WBC 10e3qµL	6700	4.0-11.0
HgB gr/dl	10.8	13.2-17
PLT 10e3qµL	496,000	140-450
CREATININE mg/dL	0.5	0.7-1.3
BUN mg/dL	24	5-25
Na mmol/L	124	135-146
K mmol/L	5.4	3.5-5.3

מה סביר שיימצא בבדיקות המעבדה האנדוקריניות שלה?

א. רמת CRTISOL בשתן מעל מהנורמה

ב. רמת TSH מתחת לנורמה

ג. תגובה מופחתת למתן ACTH

ד. תגובה מופחתת ל- LOW DOSE DEXAMETHASONE SUPRESSION TEST

79. מחלקה פנימית מבקשת ייעוץ גריאטרי על מנת להגדיר את מצבו של חולה כסיעודי, לצורך קביעת זכאות רפואית ל"קוד" של משרד הבריאות.

מה תהיה ההמלצה?

א. לא ניתן להגדיר אף חולה כ"סיעודי" מבלי שעבר ניסיון שיקומי

ב. אם החולה עומד בהגדרות הקליניות, אפשר להמליץ על הגדרתו כסיעודי, אך רק גריאטר ממשרד הבריאות יכול לאשר זכאות ל"קוד"

ג. אם החולה עומד בהגדרות הקליניות, אפשר להמליץ על הגדרתו כסיעודי ולאשר זכאות ל"קוד"

ד. רופא המחלקה יכול להגדיר חולה כסיעודי ואין צורך ביעוץ גריאטרי

80. איזה מהמדדים נכללים באומדן NORTON?

א. גיל, משקל, גובה ורמת חלבון בדם

ב. מצב פיזי, מצב מנטלי, פעילות יום יומית, ניידות ושליטה על הסוגרים

ג. גיל, משקל, חלבון ומצב תפקודי

ד. מחלות רקע, מצב קוגניטיבי ו- TOTAL LYMPHOCYTE COUNT

81. איזה מהבאים מהווה גורם סיכון לקרצינומה של הערמונית?

א. מוצא מרוקאי

ב. סיפור משפחתי

ג. תזונה דלת שומן

ד. חשיפה לתרופה ממשפחת ה- 5α-Reductase Inhibitors

82. אילו שינויים אנטומיים בלב הקשורים לגיל, <u>נחשבים לפתולוגים</u>:

א. עליה במסת שריר הלב והתעבות דופן החדר השמאלי

ב. שקיעת סידן ושומן ברקמת מסתמים

ג. היווצרות של אטרומה בדופן כלי הדם הקורונריים

ד. פיברוזיס תאי מערכת ההולכה

83. לפי המחקר Summative Effects of Vascular Risk Factors on the Progression of Alzheimer Disease מאת Lee וחבריו מה נמצא לגבי השפעת גורמי סיכון קרדיו-ווסקולרים על דמנציה?

א. קיום 3 גורמי סיכון קרדיוו-ווסקולרים מעלה קצב הידרדרות קוגניטיבית בחולי אלצהיימר רק באלה ללא המוטציה APOE ε4

ב. קיום גורמי סיכון קרדיוו-ווסקולרים מעלה קצב הידרדרות קוגניטיבית בחולי אלצהיימר ויותר בנשאי המוטציה APOE ε4

ג. ההשפעה של גורמי סיכון קרדיוו-ווסקולרים על קצב ההידרדרות קוגניטיבית חולי אלצהיימר ניכרת רק אחרי 3 שנות מעקב

ד. בחולים עם 3 גורמי סיכון קרדיוו-ווסקולרים ערכי ה- MMSE ירדו ב- 3 שנים ב- 13-15 נקודות

84. בת 89, מאושפזת במחלקה פנימית בבית חולים כללי בשל דלקת ריאות. עד האשפוז הנוכחי גרה בביתה בגפה, נעזרה במטפלת מחוק סיעוד 5 שעות שבועיות, לרכישת תרופות והשגחה במקלחת. לאחר אשפוז של שבוע חל שיפור משמעותי במצבה. החום ירד, השיעול פחת, מדדי הדלקת המעבדתיים בירידה ניכרת. זקוקה עדיין לחמצן דרך קנולה נזאלית ("משקפיים") כדי לשמור על ריווי חמצן תקין. מבחינה תפקודית – זקוקה לעזרה רבה בכל ה-ADL.

נדרש ייעוץ גריאטרי לצורך החלטה על מסגרת שחרור מתאימה.

מהי ההמלצה במקרה זה?

א. במידה וקיים שיתוף פעולה – מתאימה לאשפוז במחלקה שיקומית

ב. אפשר להגדיר אותה בינתיים כסיעודית זמנית, להעביר למחלקה סיעודית, ולבדוק שוב בעוד כחודש האם השתפרה

ג. היות ונזקקת לטיפול בחמצן, היא מתאימה למחלקה לסיעוד מורכב

ד. אם הייתה קודם עצמאית – מתאימה למחלקה לתשושים

85. מה התיאור הנכון לגבי עלויות ומימון של מסגרות פוסט-אשפוזיות שונות?

א. מחלקה שיקומית – הקופה משלמת, אך החולה והמשפחה יצטרכו לשלם השתתפות יומית

ב. מחלקה סיעודית – המימון תלוי בהכנסות הן של החולה והן של ילדיו

ג. מחלקה לסיעוד מורכב – הגורם הממן הוא משרד הבריאות

ד. מחלקה לתשושים - העלות מתחלקת בין אגף הרווחה של הרשות המקומית לבין לשכת הבריאות

86. אין ספק שיהיה צורך בהרבה מומחים לגריאטריה בשנים הבאות.

על פי הפרסום "בני +65 בישראל" מה אחוז הזקנים בני 80 ומעלה מכלל הזקנים (בני 65 ומעלה) כיום ומה הצפי ל- 2035?

א. 10% מבני +65 הם בני +80 , ב- 2035 צפוי לעלות ל- 20%

ב. 21% מבני 65+ הם בני +80, ב- 2035 צפוי לעלות ל- 26%

ג. 26% מבני +65 הם בני +80 , ב- 2035 צפוי לעלות ל- 34%

ד. 36% מבני +65 הם בני +80 , ב- 2035 צפוי לעלות ל- 50%

87. בן 82, פנה לרופא המשפחה עקב אירועים חוזרים של התעלפות. ברקע - סובל מיתר ל"ד, השמנת יתר, סוכרת ודמנציה.

תרופות קבועות:

RAMIPRIL (TRITACE)

LERCANIDIPINE (VASODIP)

MEMANTIN (MEMOX)

DONEPEZIL (MEMORIT)

ATORVASTATIN (LIPITOR

אקו לב שנעשה לפני חודשיים תקין.

במסגרת בירור נעשה הולטר שהדגים קטעים מרובים של:

איזו מהתרופות הבאות מסבירה את הממצא באק"ג?

א. RAMIPRIL (TRITACE)

ב. LERCANIDIPINE (VASODIP)

ג. MEMANTIN (MEMOX)

ד. DONEPEZIL (MEMORIT)

88. בן 85 , תשוש בתפקוד, מתגורר לבד, מתהלך עם הליכון, נעזר במטפלת 20 שעות בשבוע. ברקע יתר ל"ד, דיכאון. אין מידע על מצבו הקוגניטיבי או הנפשי טרם האשפוז. אושפז עקב חסימת מעיים, טופל שמרנית עם רזולוציה מלאה של החסימה. הוזמן ייעוץ גריאטרי, כי הכירורג התרשם מבלבול. בשיחה עם החולה – ישנוני, מדווח על מצב רוח ירוד, אינו מתמצא במקום ובזמן, אינו מרוכז במהלך השיחה ועונה תשובות לא רלוונטיות, אינו זוכר פרטים אישיים.

מה המאפיין המרמז שמדובר בדליריום ולא בהפרעה אחרת?

א. הפרעה בזיכרון

ב. מצב רוח ירוד

ג. פגיעה בריכוז

ד. חוסר התמצאות במקום ובזמן

89. על פי הפרסום "בני +65 בישראל" מה נכון לגבי מערכת השירותים לזקנים בישראל?

א. 30% מהקשישים בישראל רשומים במחלקות לשירותים חברתיים.

ב. 42% מהקשישים בישראל זכאי חוק סיעוד

ג. 8% מהקשישים נמצאים במוסדות סיעודיים או תשושי נפש

ד. 1% מהקשישים מקבל "מענק חימום"

90. בן 82 , מתגורר בביתו עם מטפל זר. ברקע - דמנציה מתקדמת, מרותק לכיסא גלגלים, נזקק לעזרה בכל צרכי ה- ADL. בנוסף, סוכרת, אי-ספיקת לב ופרפור פרוזדורים. לאחרונה קיבל טיפול אנטיביוטי ממושך עקב זיהום בדרכי השתן. התקבל למחלקה למלר"ד עקב ירידה במצבו הכללי, אירועי שלשול מימי מרובים עד 5 ליום וחום. בקבלתו למלר"ד לחץ דם 82/45, דופק 105, סטורציה 91% באוויר חדר, חום 37.8. בבדיקת צואה- CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN חיובי.

בבדיקות המעבדה:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
WBC 10e3qµL	18,700	4.0-11.0
HgB gr/dl	13.2	13.2-17
MCV Fl	78	80-96
PLT 10e3qµL	300,000	140-450
Na mmol/L	148	135-146
K mmol/L	3.2	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	2	0.7-1.3

מה הטיפול האנטיביוטי המומלץ?

א. METRONIDAZOLE (FLAGYL) פומי

ב. VANCOMYCIN פומי

ג. METRONIDAZOLE (FLAGYL) פומי בשילוב עם LOPERAMIDE (IMODIUM) אחרי כל שלשול

ד. VANCOMYCIN פומי ו- METRONIDAZOLE (FLAGYL) תוך ורידי

91. איזה מהתהליכים הבאים קשור להתדרדרות הטבעית בתפקוד הכלייתי עם הגיל?

א. פרוטאינוריה כביטוי לפגיעה טובולרית

ב. עלייה בהתנגדות של כלי הדם בכליות וירידה בזרימת הדם לכליות

ג. הופעה של המטוריה על רקע סוכרת ויתר לחץ דם השכיחים יותר בגיל זקנה

ד. אובדן מסת הכליות בעיקר ב MEDULLA עם שימור יחסי של ה-CORTEX

92. בת 94, פנתה למרפאה עקב חוסר תיאבון וירידה במשקל. באבחון ראשוני- MMSE - 26/30 , GDS- 3/15.

לפי המאמר CHOOSING WISELY של ה- American Geriatrics Society - מה מומלץ לגבי טיפול באנורקסיה במטופלת זו?

א. הפסקת תרופות שפוגעות בתיאבון

ב. מתן תוספי תזונה עתירי קלוריות בין הארוחות

ג. מתן MEGESTEROL ACETATE (MEGACE)

ד. מתן MIRTAZAPINE (MIRO) כמעודד תיאבון

93. בן 85, עם רקע של הגדלת ערמונית שפירה (BPH), מגיע למרפאה עם אי-נקיטת שתן כרונית. מתלונן על כך ש"תמיד רטוב" ולא שם לב מתי נותן שתן. בעת ההשתנה בשירותים, מתאר קושי במתן שתן, בעיקר בהתחלה וסובל מטפטוף.

מהי האבחנה הסבירה?

א. אי נקיטת שתן מסוג דחף (urge)

ב. אי נקיטת שתן מסוג דחק (stress)

ג. אי נקיטת שתן מסוג overflow

ד. אי נקיטת שתן תפקודית (functional)

94. איזה מהשינויים הבאים בראייה הוא פתולוגי בקשישים?

א. קושי באקומודציה

ב. קושי באבחנה בין צבעים כהים

ג. ירידה בחדות הראיה

ד. קושי בהסתגלות לחושך

95. בת 84, ברקע יתר לחץ דם, עודף משקל, היפרתירואידיזם, מעשנת כבדה. במעקב שגרתי במרפאה נצפו דפורמציות באצבעות כפות הידיים.

מה מגורמי הרקע שלה הוא גורם סיכון לממצאים שנראו בידיים?

א. עודף משקל

ב. יתר לחץ דם

ג. היפרתירואידיזם

ד. עישון

שימו לב : כל השאלות הבאות הן שאלות שלילה (יש לסמן את התשובה הלא נכונה)

96. כל הגורמים הבאים נכללים בקריטריונים לשבריריות (FRAILTY) לפי FRIED **פרט ל-**

א. גיל מעל 90

ב. ירידה במשקל מעל 5 ק"ג בשנה

ג. דיווח סובייקטיבי של תשישות

ד. ירידה ב- HAND GRIP

97. בן 94, נבדק במחלקה לרפואה דחופה ושוחרר לביתו.

כל הגורמים הבאים הוכחו כקשורים לירידה תפקודית במבוגרים לאחר ביקור במחלקה לרפואה דחופה **פרט ל-**

א. מטופל שגר לבד

ב. דיכאון

ג. טיפול ביותר מ- 5 תרופות

ד. מטופל שנזקק לטיפול של עובד זר

98. בן 86, דייר מחלקה סיעודית, מאושפז עקב דלקת ריאות. הצוות המטפל מתרשם מאירועים חוזרים של אספירציה.

כל הבאים מסייעים בהפחתת סיכון ל- ASPIRATION PNEUMONIA **פרט ל-**

א. הפסקת טיפול ב- QUETIAPINE (SEROQUEL)

ב. התחלת טיפול ב- ENALAPRIL

ג. התחלת טיפול ב- OMEPAZOLE

ד. שטיפות פה עם CHLOREXIDINE במקרה של דלקת חניכיים

99. בן 83, עצמאי ב- BADL וללא חסר קוגניטיבי. ברקע - סוכרת, פרפור עליות התקפי ואינסומניה.
בשבוע האחרון סובל מברונכיטיס ומטופל באנטיביוטיקה.

תרופות קבועות:

AMIODARONE (PROCOR)

BROTIZOLAM (BONDORMIN)

FUROSAMIDE (FUSID)

APIXABAN (ELIQUIS)

AMOXICILLIN (MOXYPEN)

ECITRALOPAM (CIPRALEX)

פנה למחלקה לרפואה דחופה לאחר שנפל בביתו כשקם לשירותים בלילה.

כל התרופות הבאות יכולות להעלות סיכון לנפילות **פרט ל-**

א. AMIODARONE (PROCOR)

ב. FUROSAMIDE (FUSID)

ג. APIXABAN (ELIQUIS)

ד. ECITRALOPAM (CIPRALEX)

100. בת 93, מתהלכת עם מקל, סובלת מירידה קוגניטיבית קלה. מתגוררת עם עובדת זרה. ברקע - סוכרת עם נוירופתיה, רטינופתיה ונפרופתיה עם פינוי קריאטינין 25 מ"ל/דקה. מתלוננת על כאבים קשים בכפות הרגליים עם אופי שורף וירידה בתחושה.

כל הטיפולים הבאים אפשריים לבעייתה **פרט ל-**

א. DULOXETINE (CYMBALTA)

ב. PREGABALIN (LYRICA)

ג. מריחה מקומית של CAPSAICIN (ZOSTRIX)

ד. GABAPENTIN